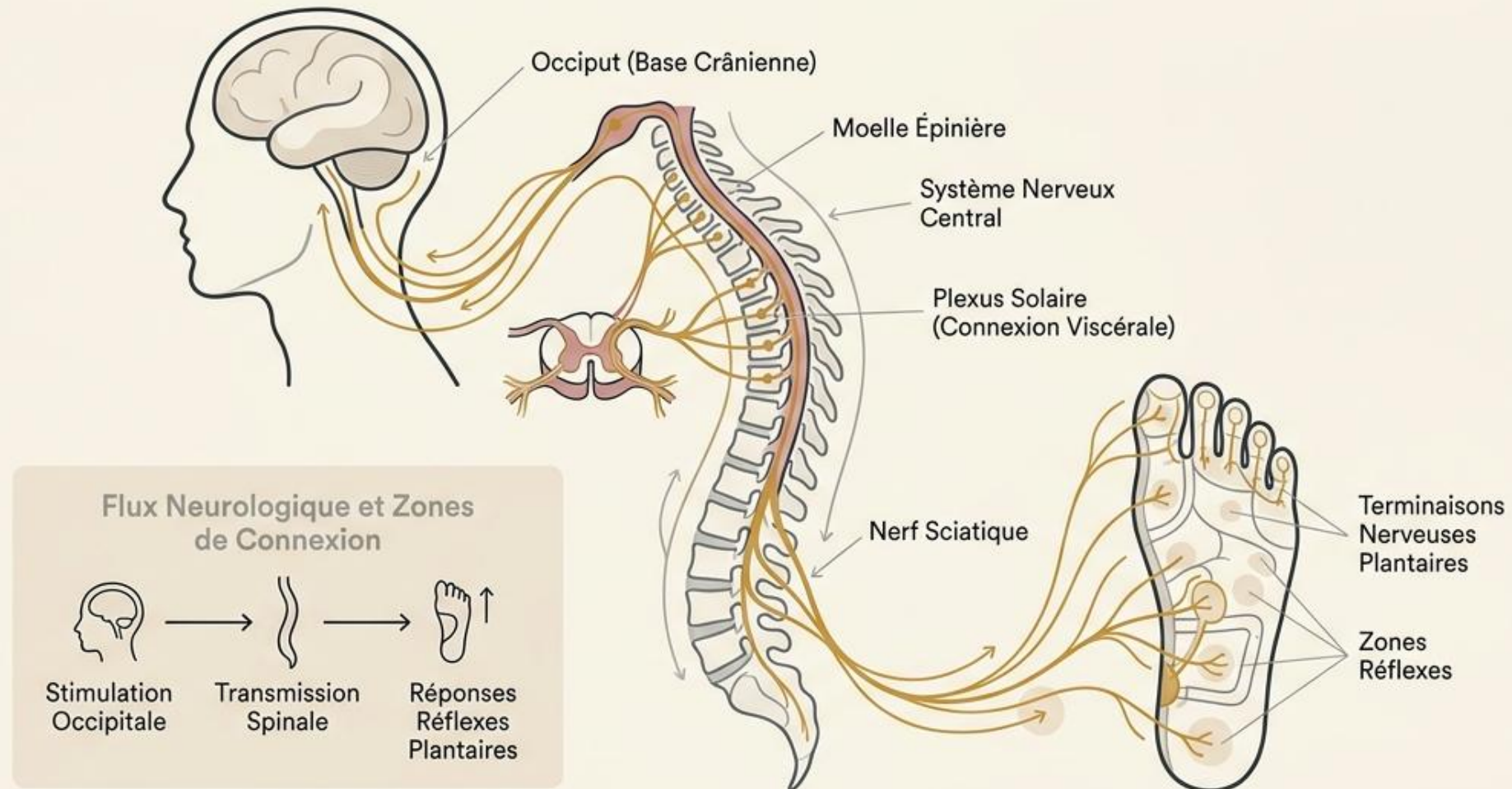


Traitement par la Réflexothérapie Occipito-Podale (ROP)

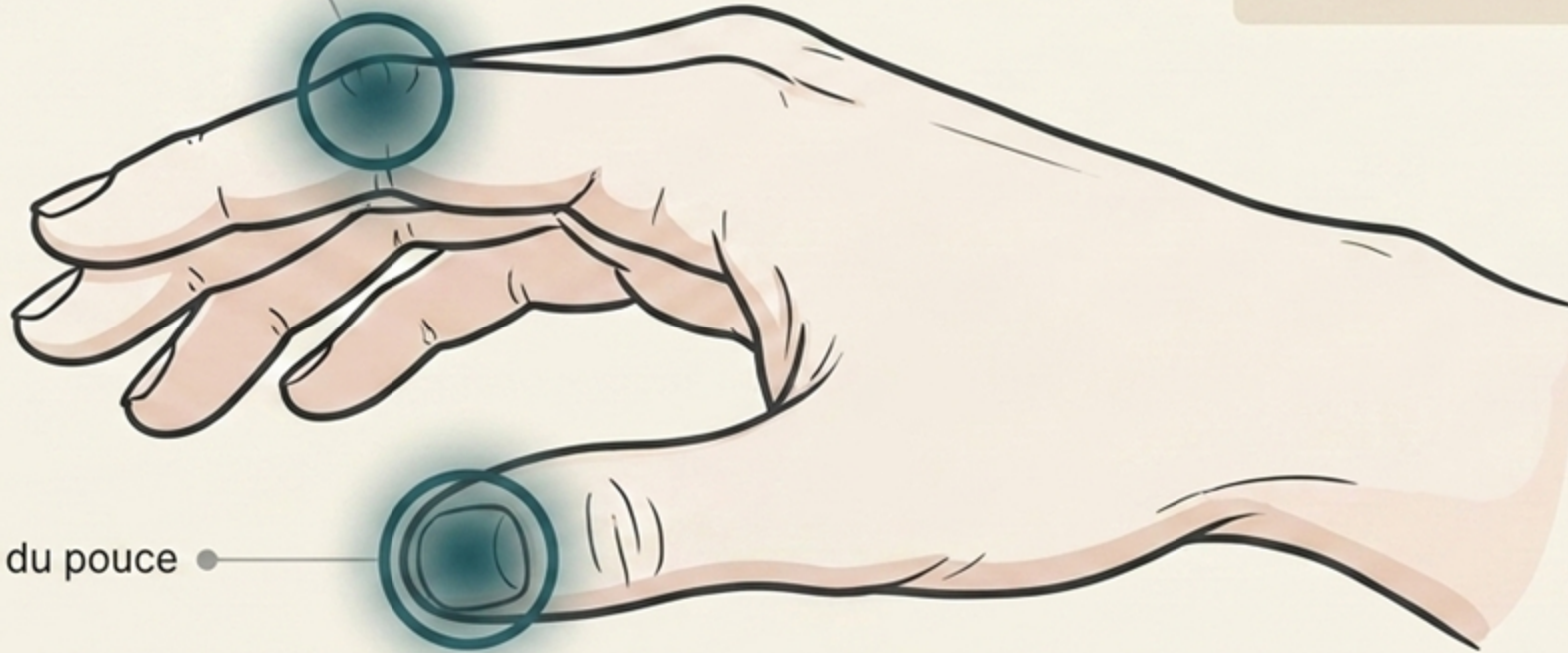
Chapitre 2 — Principes, Cartographie et Clinique



L'Exigence du Geste Thérapeutique

Inter-phalangienne
proximale de l'index

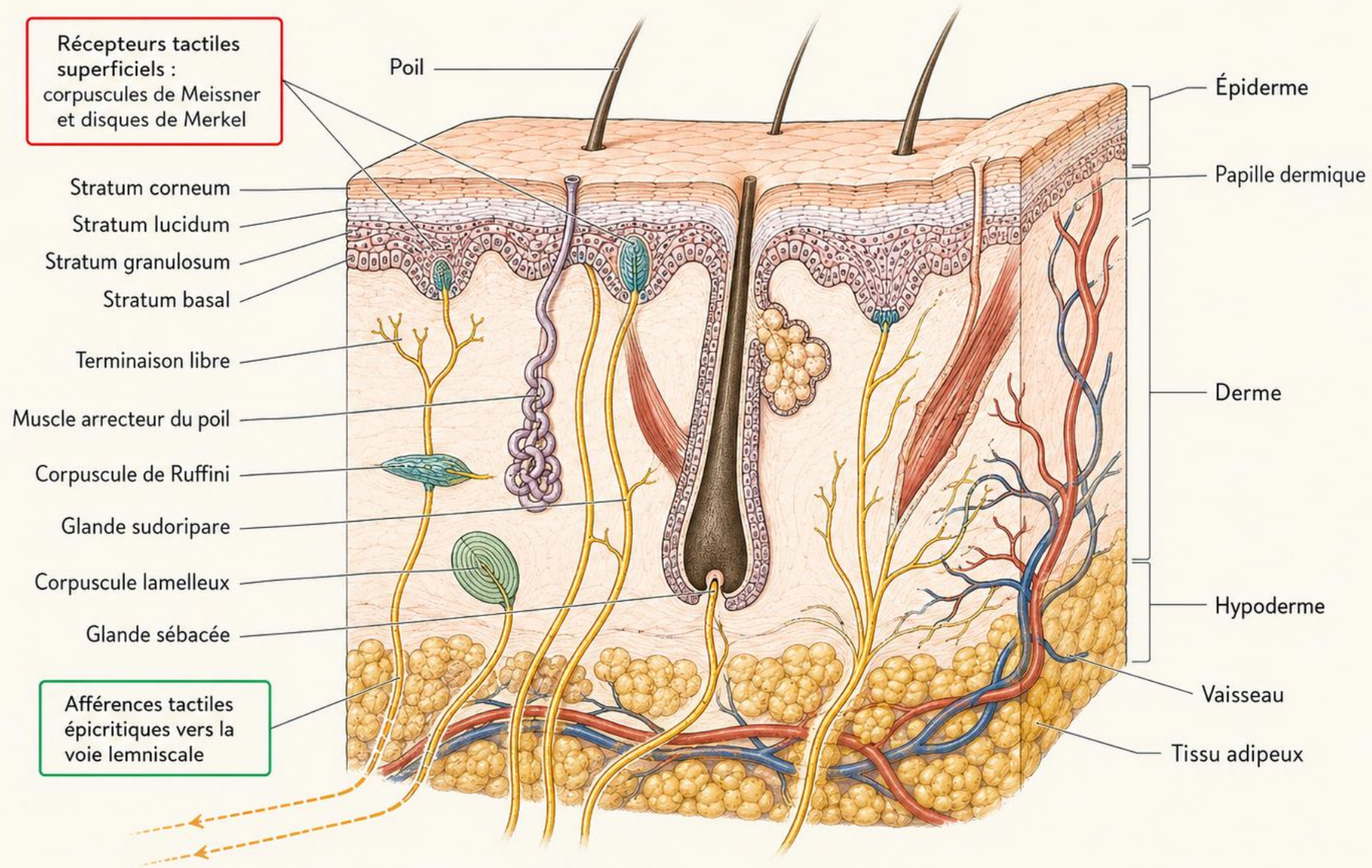
Pulpe du pouce



Une approche exclusivement manuelle, sans adjonction d'huile ou de crème, reposant sur la précision de la pression épicrotique.

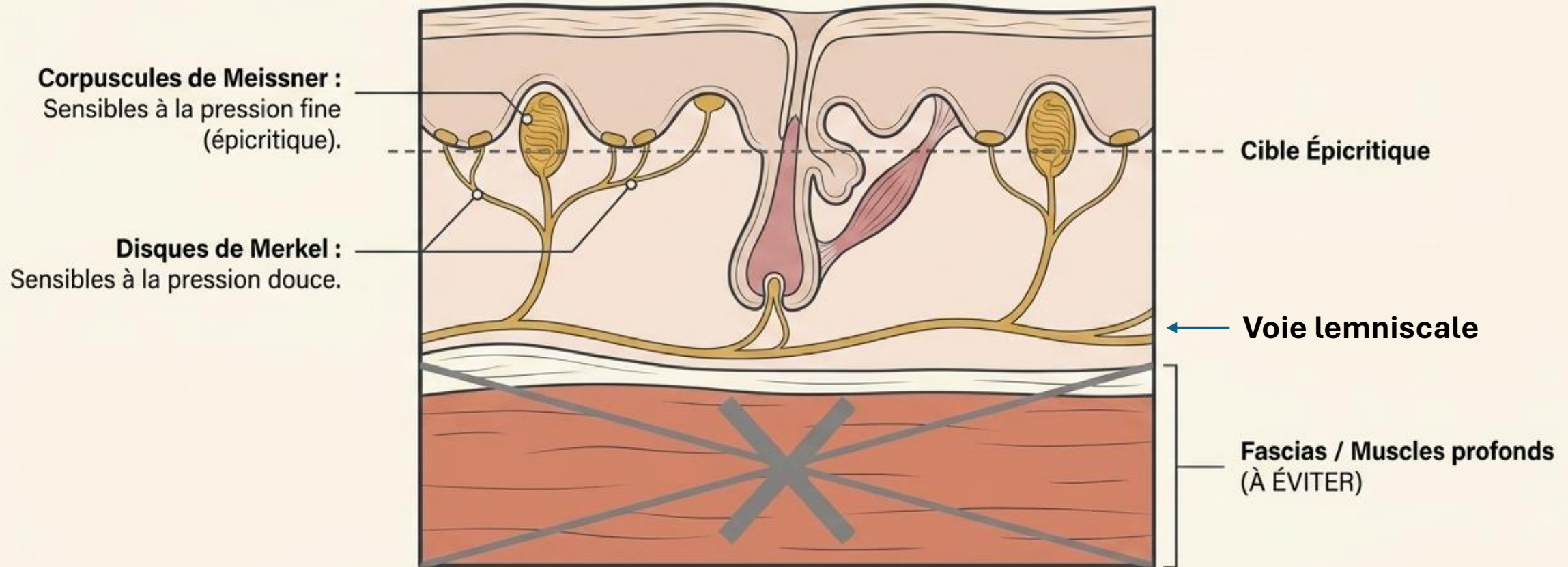
La force et la trituration sont proscrites. Plus la pression est forte, moins la lecture des repères osseux et des zones réflexes est aisée.

La peau



Représentation schématique des couches de la peau, de ses annexes et de ses principaux récepteurs tactiles superficiels.

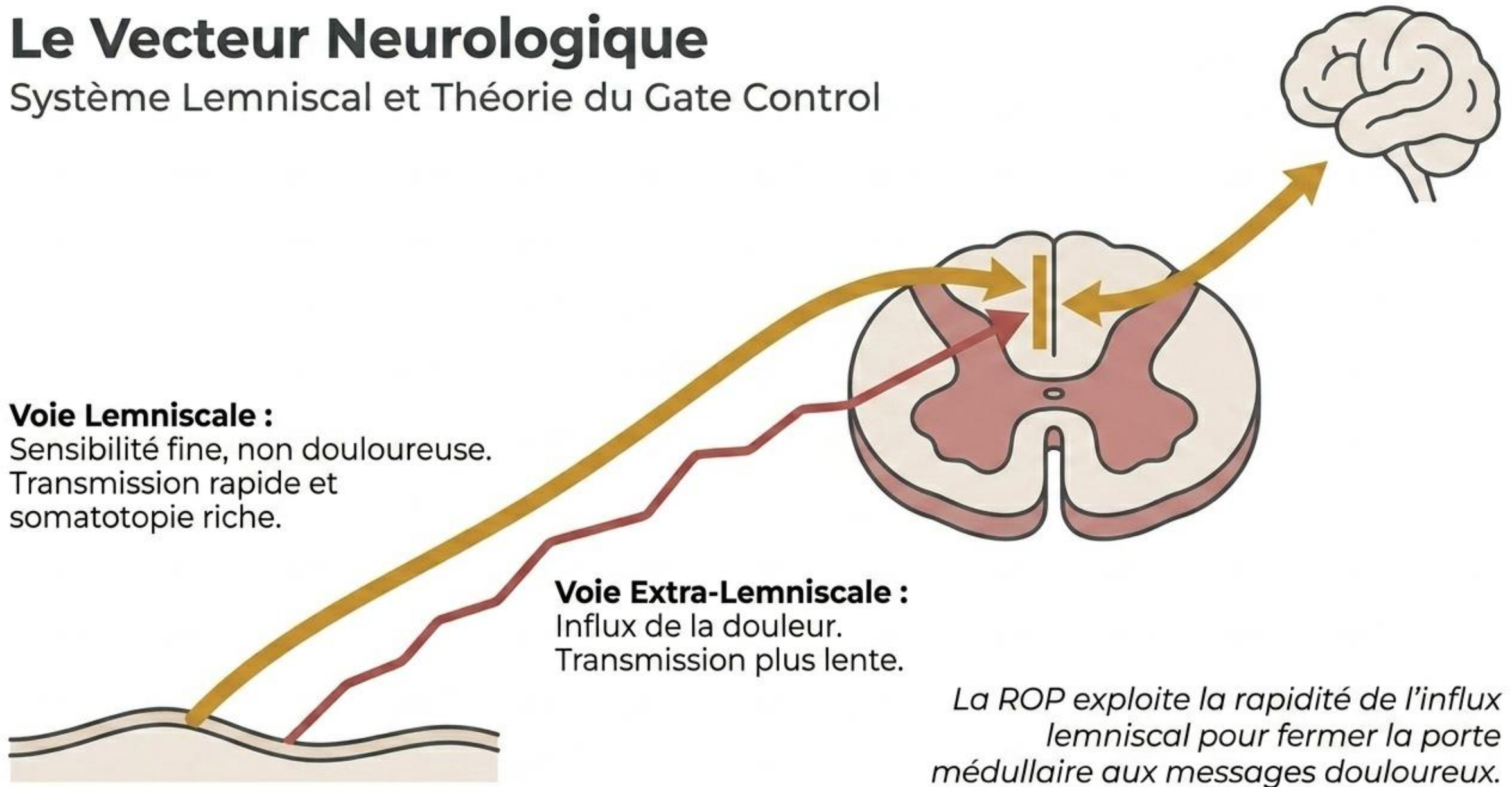
La Cible Tissulaire : Couche Épidermo-Dermique



L'objectif est la déformation de la peau repérée par la sensation de "peau de tambour".
Plus la pression est forte, plus la lecture des repères osseux disparaît.

Le Vecteur Neurologique

Système Lemniscal et Théorie du Gate Control



Chronologie Clinique : Les Trois Temps du Massage



Temps du Diagnostic Textural

Action : Recherche des rugosités, densifications, et pertes de glissement.

Ressenti patient : Sensation de petites piqûres caractéristiques.



Temps Thérapeutique

Action : Pression fine, épicritique. Mobilisation de la couche épidermo-dermique.

Objectif : Solliciter les mécanorécepteurs (sans douleur vive, synonyme de surdosage).



Temps du "Laisser-Faire"

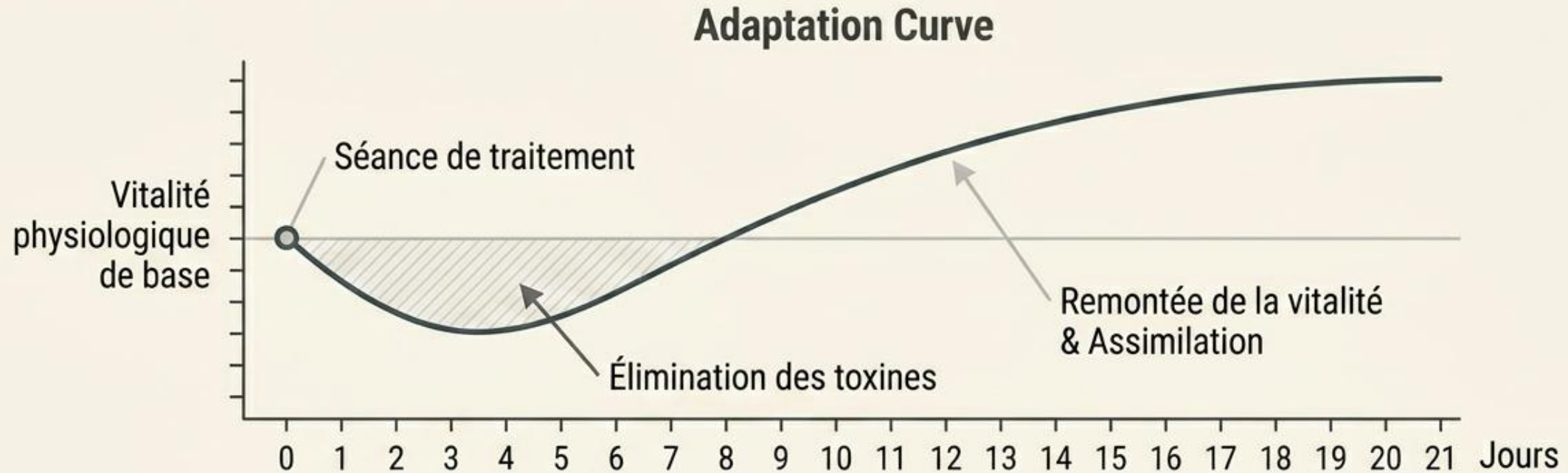
Action : Temps de latence post-stimulation. Ne rien faire.

Objectif : Permettre à l'organisme d'intégrer les adaptations neuro-végétatives.
Résultat : souplesse restaurée.



La Fenêtre d'Assimilation Neuro-Vasculaire

Pourquoi un intervalle de 3 semaines est-il requis ?



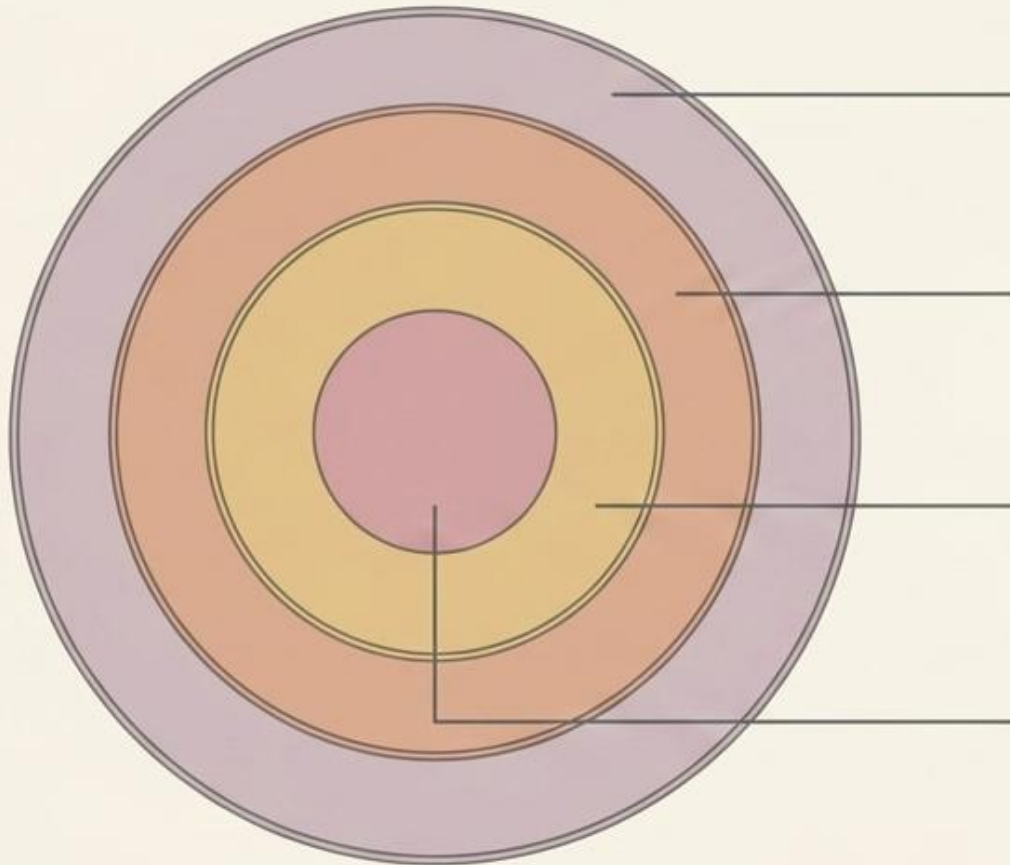
24 à 48 heures : Réactions passagères possibles (courbatures, fatigue, rêves). Témoinne de la réponse au stress positif et de l'élimination toxinique.

Semaines suivantes : Adaptation du système immunitaire, hormonal et psychique.

Des soins trop rapprochés ne laissent pas le temps aux processus neuro-vasculaires et structurels de ramener la physiologie dans les viscères. 3 séances suffisent généralement.

Hiérarchisation du Plan de Traitement

Le protocole immuable n'existe pas en approche holistique.



1. Urgences & Séquelles : Post-trauma, chirurgie, infection (priorité immédiate).

2. Fixations Dominantes : Identifiées par l'anamnèse et les tests d'écoute globale/locale.

3. Sphère Psycho-Émotionnelle : Traumatismes anciens refoulés (amygdale / hippocampe).

4. Contexte Général (SGA) : L'histoire complète des adaptations de l'individu.

Cartographie d'Intervention

Les trois sphères réflexes occipito-podales

1. Syndrome Général d'Adaptation (SGA)

Occiput-C1-C2, nerf vague (X), faux du cerveau, MRP, système veineux.

Objectif : Soutenir la régulation neuro-végétative globale.



3. Système Limbique

Amygdale, hippocampe, insula.
Balance cerveau-viscère.

Objectif : Intégrer la dimension stress et mémoire corporelle.

2. Syndrome Locorégional

Plexus prévertébral, plexus somatiques, cavités abdominale et pelvienne.

Objectif : Traiter les boucles viscéro-somatiques.

Cibles Anatomiques I : Syndrome Général d'Adaptation

Soutenir la régulation neuro-végétative avant de traiter le tissu local.

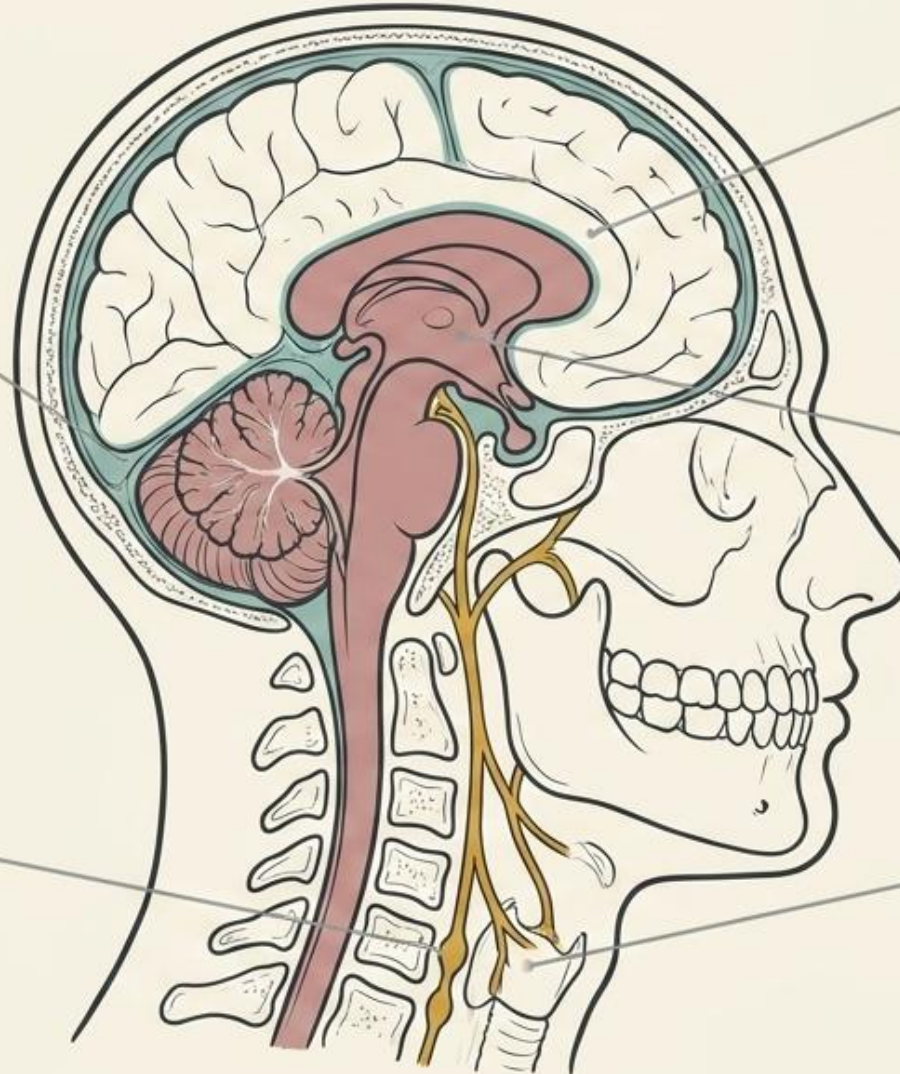
MRP (Mécanisme Respiratoire Primaire) : Occiput-C1-C2, nerfs V, X, XII, faux du cerveau.

Liquide Cérébro-Spinal : Système veineux, compression du IV^e ventricule, synchronisation SSB-S2.

Centres Supérieurs : Diencephale, tronc cérébral, hypophyse.

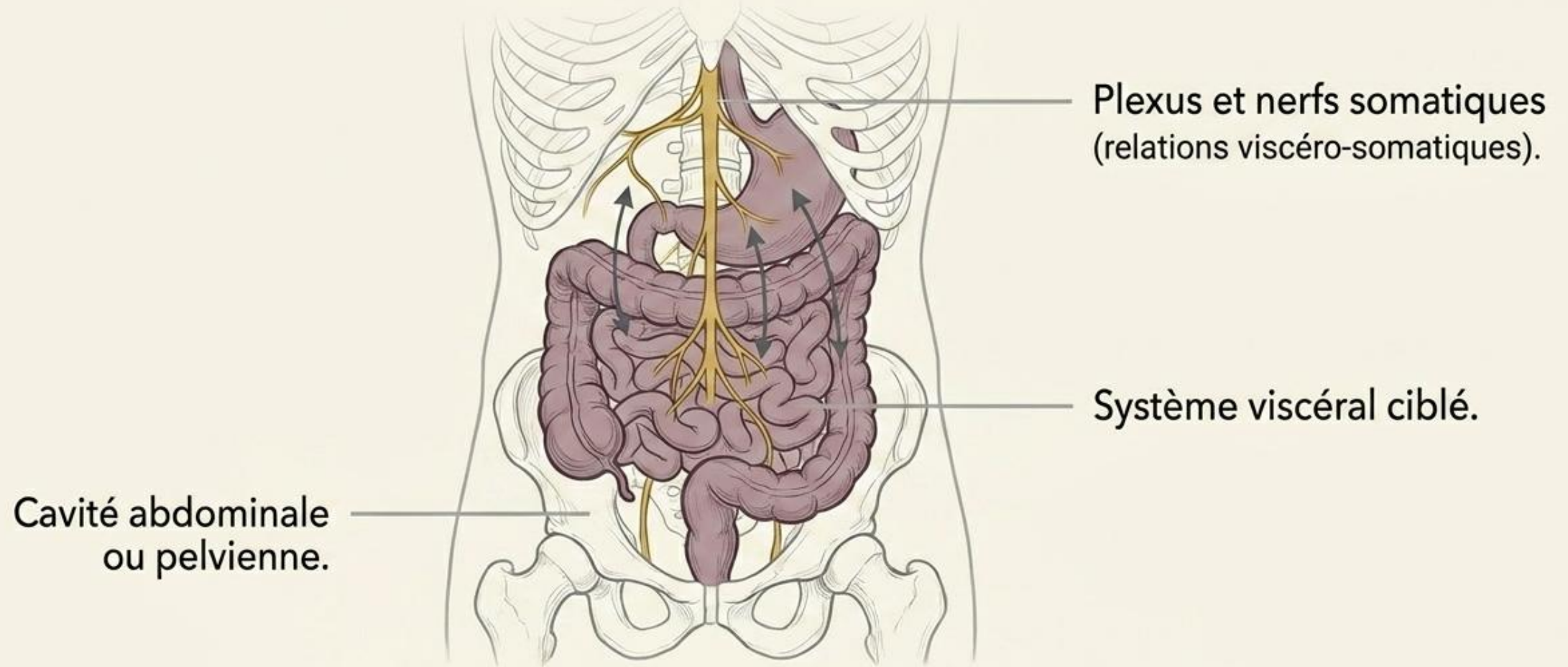
Innervation Sympathique : Colonne vertébrale, chaîne ganglionnaire latéro-vertébrale.

Système Neuro-Végétatif : Nerf vague (foramen magnum/jugulaire, hiatus œsophagien), parasympathique pelvien.



Cible II : Syndrome Locorégional

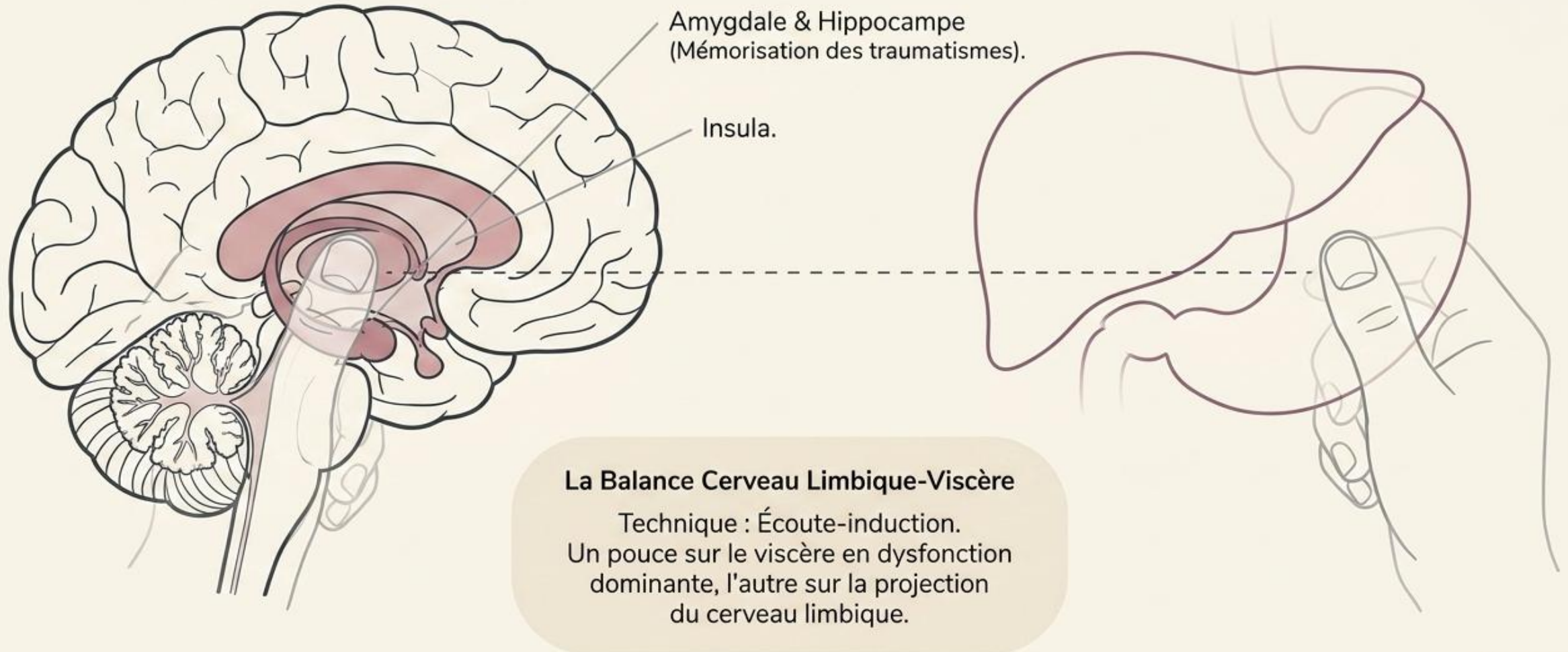
Traitement des boucles liées à la région symptomatique.



L'objectif est de relâcher les fixations locales de la cavité concernée pour restaurer la mobilité tissulaire et briser la boucle neuro-végétative entretenue par la dysfonction.

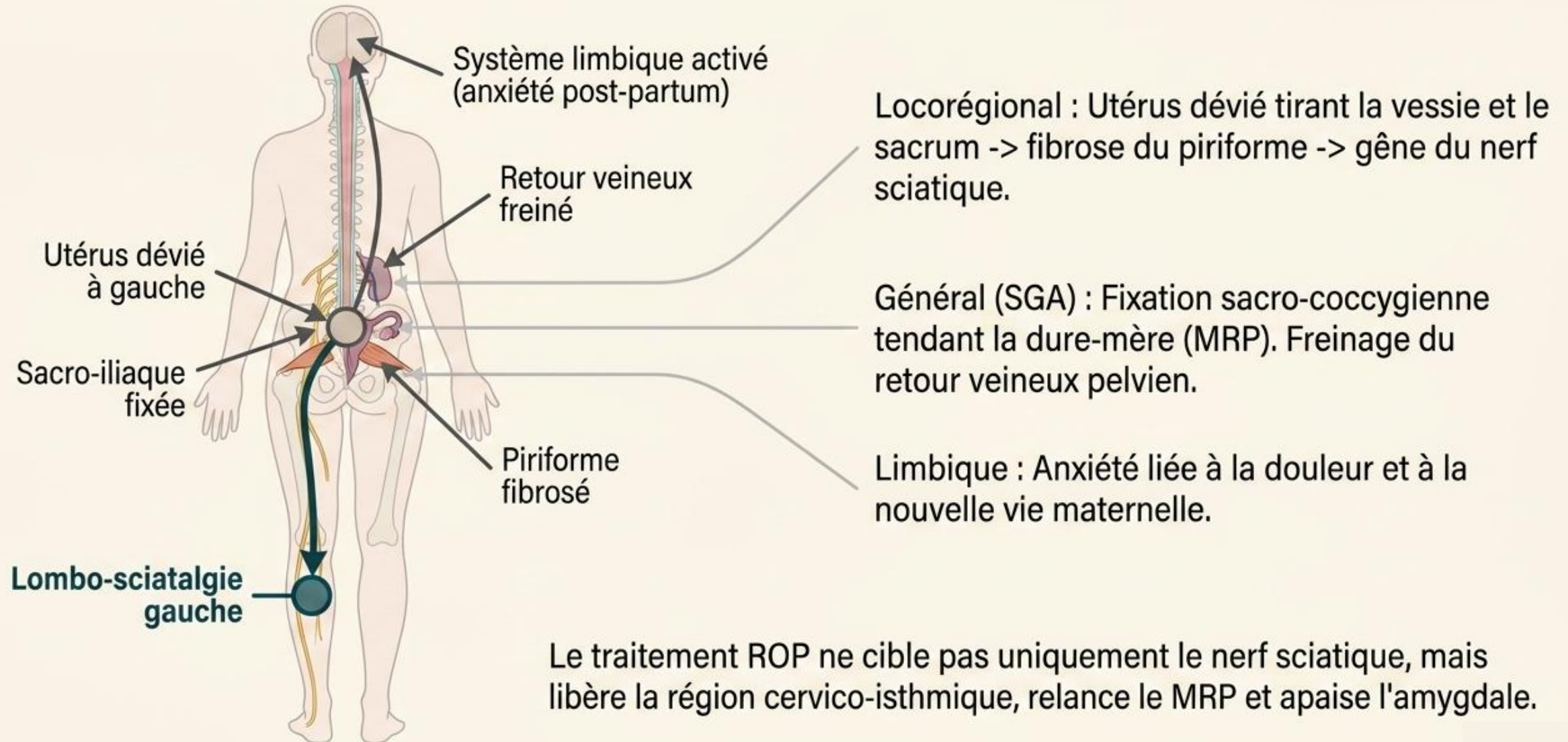
Cible III : Système Limbique

Intégration de la mémoire corporelle.



Application Clinique : Lombo-Sciatalgie Post-Partum

Patiente unipare, douleur majorée aux règles, accouchement long.



Le plan de traitement ROP ciblé pour Madame X

Piller 1 : Syndrome Général (Fondation)

- Mécanisme Respiratoire Primaire (MRP)
- Diencéphale & Tronc cérébral
- Axe hormonal: Hypophyse, Surrénales
- Retour veineux: Foie, Rein gauche
- Colonne vertébrale

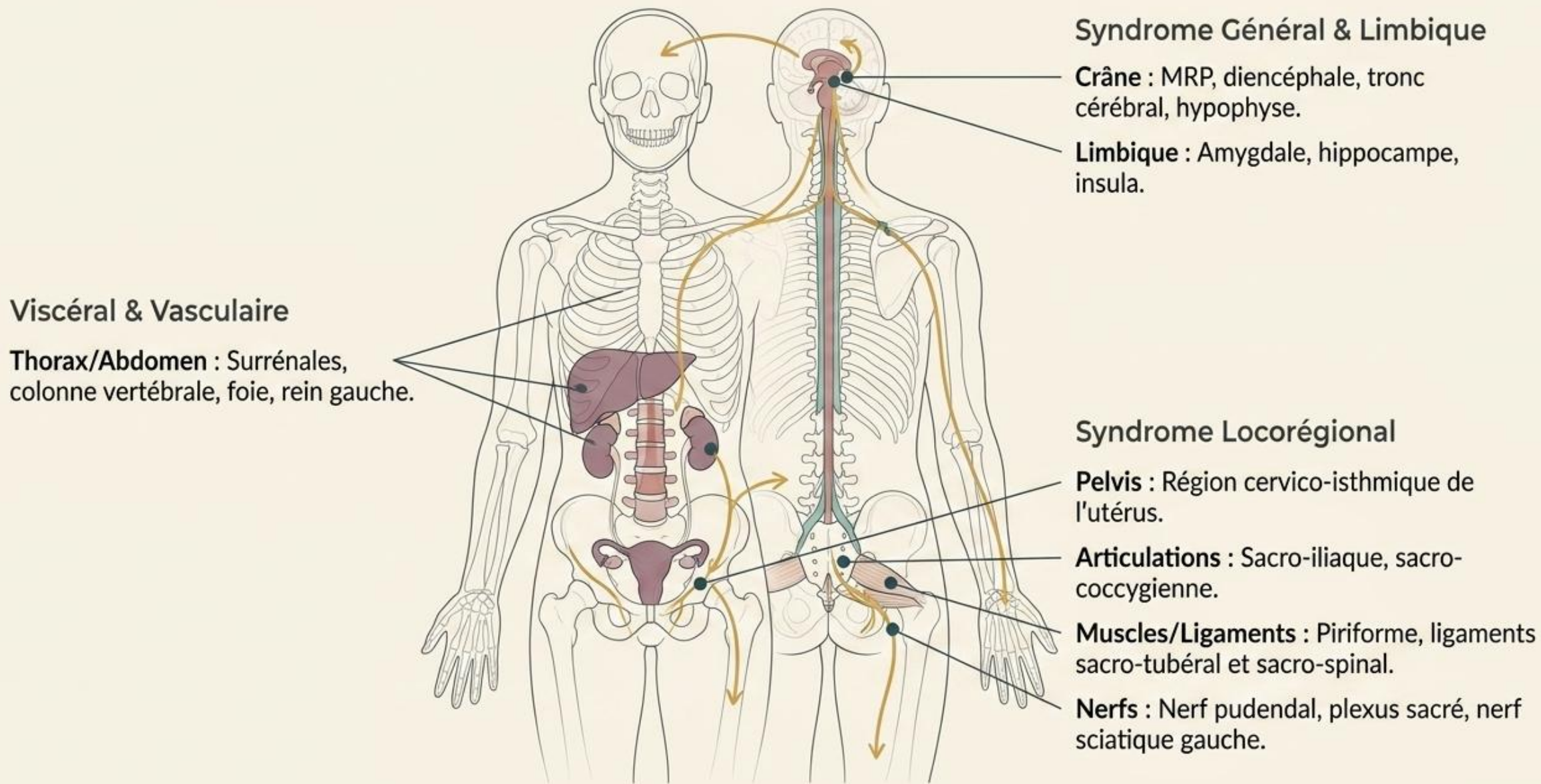
Piller 2 : Syndrome Locorégional (Mécanique)

- Région cervico-isthmique de l'utérus
- Articulations pelviennes (Sacro-iliaque, sacro-coccygienne)
- Muscle piriforme & ligaments sacro-tubéral/sacro-spinal
- Nerf pudendal & Plexus sciatique gauche

Piller 3 : Système Limbique (Intégration)

- Amygdale
- Hippocampe
- Insula

Plan de Traitement ROP (Application Cas Mme X)



Indications thérapeutiques : Le domaine des troubles fonctionnels réversibles

La ROP excelle dans les déséquilibres du système vasculo-nerveux apparus en amont de la maladie, là où l'altération anatomique tissulaire n'est pas encore entamée.



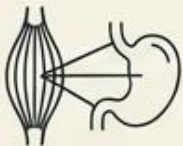
Douleurs musculo-squelettiques: Lombalgies, cervicalgies, tensions chroniques sans atteinte structurelle majeure.



Séquelles traumatiques: Ostéo-musculo-articulaires, ou atteintes réversibles des nerfs spinaux et crâniens.



Dysfonctions viscérales: Boucles neuro-végétatives et fixations tissulaires empêchant la motilité des organes.



Troubles somato-viscéraux: Douleurs projetées entre le soma et les cavités viscérales métamériques.



Terrain neuro-végétatif: Stress émotionnel, anxiété, et dérèglement du Syndrome Général d'Adaptation.

Gouvernance Clinique : Sécurité et Limites

✓ Indications (Soins Fonctionnels)	+ Signes d'Alarme (Avis Médical Requis)
Pathologies réversibles et extracellulaires.	Douleurs non mécaniques, aggravées la nuit.
Douleurs musculo-squelettiques et séquelles de traumatismes.	Douleur thoracique atypique, dyspnée.
Dysfonctions viscérales et boucles neuro-végétatives.	Sang dans les urines/selles, fièvre, amaigrissement inexpliqué.
Stress émotionnel et anxiété.	Déficit neurologique (troubles sphinctériens/sensitifs).
Soutien intégratif (ex: limitation des effets iatrogènes post-chirurgie).	

Primum non nocere. Toute suspicion de pathologie organique impose la réorientation médicale.

L'Accompagnement Global du Patient



Repos Relatif : Éviter les surcharges physiques le jour du soin.



Hygiène de Vie : Alimentation saine, hydratation soutenue, activité physique régulière.

*« Avant de chercher à guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à renoncer aux choses qui l'ont rendu malade. »
— Hippocrate*



Posture Mentale : Devenir acteur de sa santé, cultiver des pensées positives, vie sociale épanouie.



Auto-Observation : Noter l'évolution pour la prochaine séance (Douleur 0-10, sommeil, transit, énergie). L'objectivation guide la hiérarchisation future.